EXAMENS BIOLOGIQUES ET PRÉLÈVEMENTS

Fiches mémo · UE B.3 · 21 octobre 2026

> À faire avant tout geste
> Bonne personne · bonne demande · bon examen · bon contenant · bon moment · bonnes conditions.

FIL CONDUCTEUR



Le circuit qualité en 5 étapes.

Règle sécurité : si identité, prescription, contenant ou protocole ne concordent pas, je suspends et je demande validation à l'IDE.

Support construit à partir de sources accessibles ; diaporama Moodle identifié mais non récupérable. Toujours suivre le protocole local.

01 · IDENTIFIER ET PRÉPARER

AVANT LE PRÉLÈVEMENT

- Lire la demande et vérifier l’examen exact.
- Identifier activement le patient avec les identifiants de la structure ; vérifier toute discordance.
- Vérifier jeûne / horaire / traitement seulement si l’examen le demande.
- Expliquer, installer, préparer contenant, matériel, hygiène des mains et collecteur OPCT.

> Étiquetage : immédiat auprès du patient, selon procédure. Ne jamais pré-étiqueter un tube pour plusieurs personnes.

Après

- Date + heure + préleveur + site / contexte si demandés.
- Acheminement et température selon le catalogue du laboratoire.
- Tracer le soin, incidents et surveillance.

La phase préanalytique comprend prélèvement, préparation, renseignements pertinents, transport et conservation.

02 · SANG : TUBES ET ORDRE

Tube usuel	Additif / examens repères
Bleu clair	Citrate : hémostase (TP/INR, TCA, fibrinogène).
Rouge / jaune	Tube sec / sérum : biochimie, sérologies selon labo.
Vert	Héparine : plasma, biochimie selon labo.
Violet / rose	EDTA : NFS, formule, plaquettes.
Gris	Antiglycolytique : glucose / demandes ciblées.

> Ordre général : hémocultures → citrate → sérum → héparine → EDTA → antiglycolytique.

Couleurs et examens varient. Vérifier l’additif et le manuel du laboratoire. Le tube citraté doit atteindre le repère. Avec ailettes, une purge peut être nécessaire pour remplir la tubulure.

Les tubes anticoagulés se mélangent par retournements doux selon la notice ; jamais de secouage.

03 · URINES, SELLES, RESPIRATOIRE

ECBU

- Milieu de jet dans un pot stérile ; toilette et consignes selon protocole.
- Avant antibiothérapie si possible, sans retarder une urgence ; noter traitement / heure si demandé.
- Transport rapide ou conservation selon laboratoire.

URINES 24 H

- Noter début et fin ; recueillir toutes les mictions pendant la période complète.

SELLES / EXPECTORATION

- Pot propre adapté ; éviter urine, eau ou salive selon examen.
- Distinguer expectoration profonde et salive ; vérifier milieu, délai et température.

> Erreur fréquente : échantillon contaminé, mauvais pot, recueil incomplet ou heure manquante.

04 · HÉMOCULTURES ET MICROBIOLOGIE

HÉMOCULTURE = sang + flacons avec milieu de culture

- Asepsie stricte : peau, septum des flacons, séchage selon protocole.
- Avant antibiothérapie si possible, sans retarder une prise en charge urgente.
- Flacons aérobie / anaérobie : ordre selon dispositif / notice.
- Volume selon repère fabricant, âge et poids ; ne jamais transposer le volume adulte à l’enfant.
- Étiquette sans masquer code-barres / repère de remplissage ; transmission rapide.

ÉCOUVILLON / PLAIE

- Bon site, bon dispositif, prélèvement aseptique. Un écouvillon de surface peut refléter une colonisation.

> Alerte : contamination cutanée d’une hémoculture = risque de faux positif et d’examens / traitements inutiles.

05 · SÉCURITÉ, SURVEILLANCE, RÔLE

SURVEILLER

- Tolérance, douleur, malaise vagal, saignement, hématome.
- Après ponction artérielle : compression et surveillance renforcées selon protocole.

PRÉVENIR LES ERREURS

- Identité non concordante : suspendre, prévenir, appliquer l’identitovigilance.
- Tube citrate sous-rempli, tube coagulé, hémolyse ou délai inadapté : prévenir l’IDE / le laboratoire.
- Ne jamais cacher une non-conformité ni modifier un étiquetage sans procédure.

ESI : réaliser seulement dans le cadre appris, autorisé et encadré. En cas de doute : demander à l’IDE référent.

> OPCT : élimination immédiate dans le collecteur ; ne jamais recapuchonner ni désadapter à la main.

06 · À CONNAÎTRE PAR CŒUR

Les 6 repères essentiels
1. Identité et demande concordantes ; étiquetage immédiat auprès du patient.
2. Tube choisi selon additif et consignes du laboratoire, jamais selon la couleur seule.
3. Ordre de prélèvement : repère local, selon matériel et protocole.
4. Citrate : remplissage jusqu'au repère ; sous-remplissage = non-conformité possible.
5. Hémoculture : asepsie stricte, volume adapté et transmission rapide.
6. Doute ou discordance : suspendre, prévenir l'IDE et tracer.

Avant / pendant / après

Avant : vérifier identité, demande, conditions et contenant. Pendant : respecter asepsie, matériel et sécurité. Après : identifier, acheminer, surveiller et tracer.

La couleur des tubes, leur ordre précis, les volumes et les délais dépendent du dispositif et du laboratoire destinataire : connaître la règle locale applicable.

07 · QUIZ EXPRESS ET RÉFÉRENCES

1. Pourquoi vérifier l’identité avant le prélèvement ?

Pour attribuer avec certitude le résultat au bon patient.

2. Quel défaut rend un citrate potentiellement non conforme ?

Un sous-remplissage, qui fausse le rapport sang/citrate.

3. Que faire si le contenant prescrit manque ?

Suspendre et demander une validation ; ne pas substituer au hasard.

4. Quelles étapes tracer ?

Date/heure, préleveur, examens, site et renseignements requis, incident, acheminement.

Sources : CSP L.6211-1 et L.6211-2 ; arrêté du 20/02/2026 relatif au DE infirmier ; EFLM-COLABIOCLI 2019 ; AP-HP CHU Bordeaux (15/12/2025) ; SYNLAB 2025. Protocoles locaux prioritaires.

Impression : A5 paysage, recto-verso, retournement bord court. Marges de perforation sécurisées.

MÉMO A5 — Classer les prélèvements

UE B.3 · La demande et le laboratoire déterminent le contenant, le volume, le délai et la conservation.

Échantillon	Examens / prélèvement	Point-clé
Urines	BU · ECBU · 24 h · RAC · PCR IST	BU = orientation ; ECBU = milieu de jet ; PCR parfois premier jet ; 24 h = tout recueillir.
Selles	Coproculture · parasites · toxines · FIT	Pot/kit adapté ; aucune contamination urine/eau ; FIT = kit dédié.
Respiratoire	ECBC · écouvillon ORL · aspiration/LBA	ECBC = toux profonde, sécrétions bronchiques, pas salive seule.
Peau/muqueuses	Plaie · pus · vaginal/cervical/urétral · ORL/œil	Site précis ; aspirat profond si indiqué ; milieu et écouvillon adaptés.
Liquides stériles	LCR · pleural · ascite · synovial	Prélèvement spécialisé ; laboratoire prévenu, transport rapide.
Capillaire	Glycémie / test rapide	Mains propres-sèches ; lancette unique ; ne pas comprimer fortement.

URINES : LES 4 RECUEILS À NE PAS CONFONDRE

BU	ECBU	24 heures	PCR urine
Urine fraîche, récipient propre/sec ; lire la bandelette au temps prescrit. Orientation, pas culture.	Hygiène selon protocole ; jeter premier jet, recueillir milieu dans pot stérile. Sonde : port dédié, jamais poche.	À T0, vider/jeter urine initiale ; noter heure. Tout recueillir, puis ajouter miction à T0 + 24 h. Noter diurèse si demandée.	Certains tests demandent premier jet/volume précis. Suivre le kit ; ne pas appliquer le recueil ECBU.

MÉMO A5 — Recueil, transport, sécurité

Selles : récipient indiqué, échantillon représentatif, sans urine ni eau ; acheminement selon labo. FIT = kit séparé.

Expectoration : pot stérile, toux profonde, pas salive seule. Écouvillon : site exact et milieu prescrits.

Plaie : privilégier le prélèvement profond/aspirat si indiqué ; préciser site, profondeur et traitement pertinent.

LCR et autres liquides stériles : prélèvement spécialisé ; contacter rapidement le laboratoire ; pas de température universelle.

Sonde urinaire : port prévu désinfecté et technique aseptique ; jamais prélèvement dans la poche.

AVANT

Prescription · identité · site · préparation · bon contenant · expliquer · matériel et sécurité.

PENDANT

Hygiène des mains · asepsie adaptée · recueil sans contamination/dilution · respecter son champ de compétence.

APRÈS

Fermer · identifier auprès du patient · heure/site/préleveur · transport-conservation du labo · tracer · surveiller.

À mémoriser : bon patient, bon échantillon, bon contenant, bon délai. Discordance ou recueil incomplet ? Le signaler et demander la conduite à tenir. Le protocole local prime.

Repères : HAS (infections urinaires, mise à jour 2025) ; AP-HP (manuel de prélèvements, procédures illustratives).